جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : حوريه عويس صالح سيد
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** كرداسه **العنوان :** برك الخيم
رقم البطاقة : 27506022102586 **رقم التليفون :** 01159742075 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 18-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 02-06-1975 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام تصوير مقطعي للصدر والبطن والحوض بالصبغة [11129] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: حوريه عويس صالح سيد
National ID: 27506022102586

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of chest, abdomen and pelvis.

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



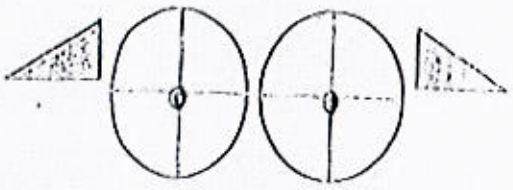


National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

MDT FORM

Name	خديجة موسى عباس
Age	35
MRN	S.M.N: ٨١٠٤٢٠١٠٠٨
ID	٢٨٠١٤٤٥٠٤٢٠١٨
Co morbidity	٢٠٢١ / ٢٦٥٩



Clinical Data

Bx:	SM:
IHC: ER: PR: Her1: Ki67:	Mets Workup:
T3 N1 M0.	
COMMENT:	

MDT OUTCOME & PLAN

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Name: حوريه عويس صالح **MR. :** 2635	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

MDT 18/11/2025: The patient received PORT AI+ZOLADEX CDK46 from NGO FEMARA CALCIUM 1*1*90 ONE ALPHA ZOLADEX 10.8.

Pt came today for zoladex, femara, supp tt for 3 mn pt finished PORT 1-2-2026 CDK 4/6 from NGO>> still pending.

Zoladex+femara +supportive*3m next clinic :7/10/2026.

تحريرا في ,

التاريخ :	**20-09-2026**	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : ايه مدحت بدوي محمد

يعتمد ,

1339

Name : KHADIGA MOUSA ABBAS
Date : 06-01-2026 11:29
Branch : Portable
Medical No. : GR1-260106112923STD1312211075237 48902
Ref.Physician Prof :
Ins.Company

MRI OF THE BRAIN

Technique :
Axial T1, T2 ,FLAIR,
Coronal T2
Sagittal T2
Postcontrast T1

Findings:

- Right frontal intra axial SOL is seen measuring 18 x 14 mm eliciting low T1, iso intense T2 and bright FLAIR WI signal with contrast uptake. it is seen associated with surrounding edema and causing mass effect in the form of effacement of the adjacent cortical sulci.
- Mild dilatation of the ventricular system
- No midline shift or deformity
- No cerebellar or brain stem areas of altered MR signal.
- Normal cortical sulci
- No extra axial collections.
- No cerebello pontine angle masses.
- No gross posterior fossa abnormalities.\
- Partial empty sella.
- Prominent peri-optic CSF spaces bilaterally.

OPINION:

- ***Right frontal SOL ? metastatic for MR spectroscopy.***
- ***Mild involutional brain changes.***
- ***Partial empty sella with prominent perioptic CSF spaces bilaterally raising the possibility of benign increased intracranial tension for clinical correlation.***

Dr. Sherif Wagdy

M.R.I
[[DOCTYPE:MRI]]

Patient Name	: الأستاذه / خديجه موسى عباس	Request No.	: 13003580
Patient No.	: 28808102301008	Request Date	: 23/11/2025
Path No.	: 3636/25	Verification Date	: 30/11/2025
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - نفقة الدولة
Age	: 37 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Right parotid small solid mass lesion ? pleomorphic adenoma, with multiple submandibular, submental and upper cervical lymph nodes likely reactive inflammatory.
Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 23/11/2025, at 3:10 pm, Cold ischemia time is 30 seconds.

Gross Examination:
- Two gray white tissue cores measured 1 cm & 1.5 cm long, totally submitted.

Microscopic Examination:
- Histopathological examination reveals cores of salivary tissue showing infiltration by tumor formed of mildly pleomorphic epithelial cells showing eosinophilic to clear cytoplasm, arranged in sheets, nests & cribriform like pattern with lumen contining eosinopilic material.
No mitosis or necrosis in specimen received.

Diagnosis:
Right intra-parotid mass, Tru-cut biopsy:
Findings are in favor of low grade carcinoma.
- Case for further immunophenotyping including (P63, S100, DOG-1, ect.....).

Signature
Prof. Dr. Gamal Abd-El-Aty.
Dr. Mennan Hossam.

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

USTAVE/
OUSSY
INTERNATIONAL

Patient Name	: الأستاذه / خديجه موسى عباس	Request No.	: 13003580
Patient No.	: 28808102301008	Request Date	: 23/11/2025
Path No.	: 3636/25	Verification Date	: 04/12/2025
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - نفقة الدولة
Age	: 37 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc.	:	IHC No.	:
		Registered by	: .marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

CLINICAL DATA
Right small solid mass at the parotid with multiple submandibular , submental , upper cervical lymph nodes likely reactive inlammatory

NATURE OF SPECIMEN
Tru cut biopsy
Gross examination :
Technique:
- Sections were prepared from the paraffin block, processed in Bench Mark ULTRA machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter stain. The sections treated against:
S100 (Polyclonal), DOG-1, P63 (4A4).

MICROSCOPIC EXAMINATION
Examination revealed tunor cells , mixure of vacuolated cells , epidermoid cells , few cells with intracellular secretions , pushed nuclei ,surrondd by dense sclerotic stroma .No necrosis , minimal pleomorphism .No lymphovascular emboli.
IPT :
P63;Diffuse strong in tumor cells
S100:Negative
DOG1 :Negative

DIAGNOSIS
Right intra- parotid mass, tru cut biopsy :
Low grade malignant neoplasm favoring moderate grade mucoepidermoid carcinoma (P63 positive, S100 negative)

Signature

Verified by :
Dr.Heba Hasan

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

USTAVE/
OUSSY
INATIONAL

Patient Name	الأستاذه / خديجه موسى عباس	Request No.	13003580
Patient No.	28808102301008	Request Date	23/11/2025
Path No.	3636/25	Verification Date	04/12/2025
Sex	Female	Financial Category	جوستاف روسي - نفقة الدولة
Age	37 Y	Department	Out Patient
Referreing Doc.			
		Registered by	.marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Prof. Dr. Maha Guimei
Dr.Walaa Ibrahim Ghoneim

Verified by :
Dr.Heba Hasan

CAP ACCREDITED

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

CAIRO UNIVERSITY
FACULTY OF MEDICINE
PATHOLOGY DEPARTMENT

Pathology No: 68f
Name [illegible] Age: 34 Sex: female
Clinical diagnosis: Invasive duct carcinoma Hospital no: 288081023
Nature of specimen Left breast inferior margin
Department: 25b Date: 14/07/21

PATHOLOGY REPORT

Gross
Received for frozen section
- A sector of mammary tissue measured 9 5x5x4 cm with attached skin ellipse measured 9 5x4 cm. The deep surface showed wall of pervious cavity. Serial sections revealed focus measured 1x1 cm with ectatic spaces oozing pasty material. The focus was located just on deep- medial margin.
- Extra Deep : Fibrofatty and muscular tissue piece measured 4x2x1 cm.
- Extra medial : Fibrofatty tissue piece measured 6x4x2 cm

MICROSCOPIC
Examination of sections from the received sector revealed a focus of invasive malignant growth formed of tubules and cords of moderately anaplastic epithelial cells with abundant eosinophilic cytoplasm. Surrounding foci of high grade DCIS were seen. Surrounding wide resection site changes in the form of fat necrosis and foreign body giant cell reaction were seen. The superior, lateral, inferior, medial, deep, extra inferior and extra medial margins were free of tumor involvement.

DIAGNOSIS
-Residual focus of invasive duct carcinoma, NST, Grade II, with high grade DCIS and previous resection site changes.
-Free resection margins

DR PASSANT ESSAM
DR AYA MAGDY

Checked by: SM
Revised by: BY

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Khadiga Mousa Abbas Seif	Date : 28/10/2023
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 35 Year(s)
Medical ID: 3659/2021	Pat. ID: 16804

RIGHT BREAST MAMMOGRAPHY WITH BILATERAL US

Indication:

Patient had left MRM

Technique

- right breast MLO and CC views
- Bilateral ultrasound

Report:

- Scattered fibroglandular densities of the right breast (ACR B)
- No spiculated masses or grouped microcalcifications.
- Complementary ultrasound also showed no right breast solid or cystic masses
- Normal skin thickness and nipple-areola complex, with average caliber of the retro-areolar ducts.
- Nonspecific right axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free left operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- Free left infra and supra clavicular regions.

Opinion:

- Left MRM with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- No right breast suspicious findings (BIRADS 2)

Yours truly

Dr.Wafaa Ali

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

Kasr El-Ainy Center of Radiation Oncology and Nuclear Medicine
Faculty Of Medicine, Cairo University

مركز قصر العيني
لعلاج الأورام والطب النووي
كلية الطب - جامعة القاهرة

"HEMROCK"

(هيموك)

Report

Patient Name:	Gadiga Mosa Abbas sef el-nasr	Patient Age:	33
Patient Code:	Q26936	DATE	2/10/2021 12:10:30 PM

$^{99}Tc^{m}$ MDP SKELETAL SCINTIGRAPHY

Clinical history

- A patient with history of left breast neoplasm.

Technique

- Anterior and posterior whole body scans were acquired 2 hours post IV injection of 740 MBq of the tracer.

Findings

- No abnormal osseous tracer uptake is seen that would account for bone deposits.
- Degenerative changes of the spine are noted.
- Osteoarthritic changes of the both knees are seen.

Opinion

- The surveyed skeleton is free from metastatic osseous lesions.

Dr. Marwa Abd Allah, MSc

Prof. Dr. Shereen Yassin, MD

Sonography
[[DOCTYPE:SONOGRAPHY]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
شبكة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
إدارة الأشعة

Patient Name: Khadiga Mousa Abbas	Date : 13/08/2022
Exam : C.T CHEST	Age : 24 Day(s)
Medical ID:	

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST: -

Evidence of left MRM: Findings:

- Post status MRM showing surgical bed with fluid collection likely seroma measuring about 18 x 75mm.
- Fine reticulo - nodular attenuations along the anterior and lingular segment of the left upper lung lobe.
- Single sub - centimetric basal pleural based pulmonary nodule.
- No sizable hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- No gross cardiac abnormality. No pericardial effusion detected.
- No sizable osseous lytic or sclerotic lesions in the scanned skeleton.
- Upper abdominal cuts show:
  - Fatty hepatomegaly.
  - Right suprarenal gland calcified foci.

OPINION:

- ***Post status MRM showing fluid collection in the surgical bed likely seroma.***
- ***Fine reticulo - nodular attenuations along the anterior and lingular segment of the left upper lung lobe, likely post inflammatory sequel.***

Dr. Mohammed Mahjoub

Signature Prof. Mohamed Gomaa

14/08/2022 03:52 م

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]